جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : مريم سعد شحاته خليل
المحافظة : سوهاج **الحي / المدينة :** المراغه **العنوان :** -
رقم البطاقة : 28501212605608 **رقم التليفون :** 01094912707 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 21-01-1985 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض بالصبغه [11127] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: مريم سعد شحاته خليل
National ID: 28501212605608

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



مريم
سعد شحاته خليل
الشورانيه
مركز المراغة - سوهاج

٢٨٥٠١٢١٢٦٠٥٦٠٨

JR0572222



٢٨٥٠١٢١٢٦٠٥٦٠٨ ٢٠٢٢/١١
محامى حر

أنثى مسيحية متزوجة
بهاء حنا فرج حنا

١٠ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/١١/٢١



National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

جوستافروسي انترناشونال مصر

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية هي صحة مصر

MDT FORM 9 9 / 2025 G

Name	مريم مصطفى	MRN	306/2025
		ID	٢٨٥٠١٤١٤٦٠٥٦٠٨
Age	40	Phone	01094912707
Menopausal status	Pre	Marital status	
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	
CO morbidity			

Clinical Data

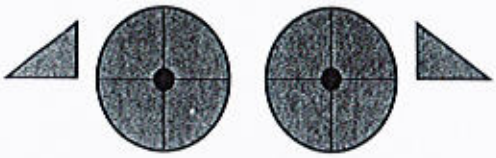
BX: IDC

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
0/8	0/8	-ve	35

Sonomammography:

Mets Workup: PET/CT → No Mets

R CT4bN2 L



TNM

Recommendations: 40 Yrs old Arab Patient, Premenopausal, A Case of Lt breast Cancer TNBC received 4 DDAC + 4 TC (one of them without Taxel) last (28/8/2021) for your sagital assessment

28/8/2021

MDT OUTCOME & PLAN: Post NACT for Lt MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
M. Kelz					

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: مريم سعد شحاته خليل	
MR. : 8138	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

On examination, the patient demonstrated dry desquamation secondary to radiation therapy and had completed placement of a port for ultrasound evaluation of a seroma.

تحريرا في ,

التاريخ :	**21-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : خالد عبد العزيز محمد كمال

يعتمد ,

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Mariam Saad Shehata Khalil	Date : 30/08/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 40 Year(s)
Medical ID: 306/2025	Pat. ID: 98186

FOLLOW UP BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:

Left breast pathologically proven malignant mass, treated by NACT, for assessment

TECHNIQUE:

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

REPORT:

- Very dense breasts, (ACR D).

LEFT BREAST:

- The irregular dense mass is still seen associated with nipple retraction, yet exhibiting significant decrease in size, complementary U/S still revealed the underlying irregular heterogenous mass, measuring 5.5x1.2cm, previously 8x4cm.
- No definite pathological axillary node is seen.
- Few benign calcifications are also seen.

RIGHT BREAST:

- No solid or cystic masses.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex.
- Nonspecific axillary nodes.

OPINION:

- Regressive course of the left breast locally advanced malignant process, (BIRADS 6).
- Right normal study, (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name	: الأستاذة / مريم سعد لطفي خليل	Request No.	: 13008578
Patient No.	: 28501212805608	Request Date	: 11/02/2025
Path No.	: SR-178/25	Verification Date	: 27/02/2025
Sex	: Female	Financial Category	: برنامج دار السلام - فئة الدولة
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.
Nature of Specimen: Slide revision of tru cut biopsy.

Gross Examination:
- One paraffin block labeled by (25001374) and one slide were received.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), Ki67 clone (30-9), GATA3 clone (L50-823), & E-Cadherin clone.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
* Ductal carcinoma in situ: Not detected.
* Perineural invasion: Not detected.
* Angioinvasion: Not detected.
* Microcalcifications: Not detected.
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- GATA3: Positive.
- E-Cadherin: Positive.
- ER: No nuclear reaction of tumor cells (score 0/8).
- PR: No nuclear reaction of tumor cells (score 0/8).
- Her2: No membrane reaction of tumor cells (score 0).
- Ki67: 35% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II.
IPT:

Verified by :

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / مريم سعد شحاته خليل	Request No.	: 13008578
Patient No.	: 28501212605608	Request Date	: 01/02/2025
Path No.	: SR-178/25	Verification Date	: 27/02/2025
Sex	: Female	Financial Category	: أولاد دار السلام - تغطية الدولة
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 35% of tumor cells.

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Rana Fathy
Dr. Yasmine Essam

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: Mariam Saad Shehata	**Date: 2/1/2025**
Referred by: Prof. Hanan Aziz	**ID:30191121**

F18-FDG PET/CT STUDY

Clinical History:

- Female patient with left breast cancer, for initial assessment.

Technique:

- Radiopharmaceutical: 18F FDG.
- PET/CT images were acquired from the skull base through the upper thighs & CT images were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- Additional notes: SUV max normalized to body weight was used.

COMPARISON: No previous PET CT studies.

FINDINGS:

Head and Neck:

- No hyper-metabolic FDG avid cervical LNDs
- No FDG avid thyroid nodules
- Physiologic FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands, and larynx.
- Normal diffuse brain activity with NO hypermetabolic brain lesions.

Bilateral breasts (locoregional)

- **Dense left breast parenchyma showing ill defined UOQ FDG avid lesion measures about 3.5x2.5cm with SUVmax~5.2, For further assessment with MRI study.**
- **Multiple FDG avid left subpectoral and axillary LNs the largest measures 1.8cm with SUVmax~4.7.**
- No FDG avid right breast mass lesion .
- No FDG avid right axillary LNs.

Chest:

- There is no hypermetabolic mediastinal or axillary lymphadenopathy.
- NO FDG avid lung nodules or masses detected.
- No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
- Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

- There is no hypermetabolic abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- The liver is mildly enlarged showing homogenous parenchymatous texture with NO FDG avid focal lesions detected.
- The spleen is of average size with NO FDG avid focal lesions detected.
- Cholecystectomy surgical clips.
- The pancreas shows normal FDG avidity.
- There are no active adrenal nodules.
- Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder

Musculoskeletal:

- Normal FDG activity is seen over the axial skeleton. No focal active blastic or lytic bone lesions detected.

IMPRESSION:

- **Dense left breast parenchyma showing ill-defined UOQ FDG avid lesion, For further assessment with MRI study.**
- **Multiple FDG avid left subpectoral and axillary LNs, likely metastatic.**

Thanks for referral,

Dr. Noura Adel, MD
Radiology Consultant

Dr. Esraa Roshdy, MD
Nuclear Medicine Consultant

19057 شارع سكة الامام - السيدة زينب - القاهرة
1 Sekket Al Emam st. - Al Sayeda Zeinab - Tel: 02 27351500 (30 Lines) - Fax: 19057
www.57357.com medical.imaging@57357.com

PET Scan
[[Dr. Esraa PET_SCAN]]

جمهورية مصر العربية
نقابة المحامين الفرعية
بسوهاج
Sohag Branch Bar Association

الاستاذ الدكتور / مدير مستشفى دار السلام للاورام

تحيه طيبه وبعد"""

تشهد نقابة المحامين بأن ٠

الاستاذة/ مريم سعد شحاته المحامية

والمقيدة تحت رقم / ٣٦٧٧٢٢ استئناف

مشتركه بمشروع العلاج لعام ٢٠٢٥م

وغير خاضعه للتأمين الصحي ٠

وتفضلوا بقبول وافر التقدير"""

مسؤل العلاج

تحريرا في / ٥ / ٤ /٢٠٢٥

القائم بأعمال النقيب

ا/ احمد ابو حساب

المحامى بالنقض

العنوان : طريق أسيوط سوهاج ــ أمام بنك الإسكان والتعمير ــ سوهاج

NON-NGOS-LETTER
[[DOCTYPE:OTHER_NON_NGOS_LETTER]]

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



مريم
سعد شحاته خليل
الشورانيه
مركز المراغة - سوهاج

٢٨٥ ٠١ ٢١ ٢٦ ٠٥٦ ٠٨

JR0572222

٢٨٥٠١٢١٢٦٠٥٦٠٨ ٢٠٢٢/١١
محامى حر

انثى مسيحية متزوجة
بهاء حنا فرج جنا
١٠ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/١١/٢١

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

Patient Name: Mariam Saad Shehata Khalil	Date : 30/08/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 40 Year(s)
Medical ID: 306/2025	Pat. ID: 98186

FOLLOW UP BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:
Left breast pathologically proven malignant mass, treated by NACT, for assessment

TECHNIQUE:
- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

REPORT:
- Very dense breasts, (ACR D).

LEFT BREAST:
- The irregular dense mass is still seen associated with nipple retraction, yet exhibiting significant decrease in size, complementary U/S still revealed the underlying irregular heterogenous mass, measuring 5.5x1.2cm, previously 8x4cm.
- No definite pathological axillary node is seen.
- Few benign calcifications are also seen.

RIGHT BREAST:
- No solid or cystic masses.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex.
- Nonspecific axillary nodes.

OPINION:
- Regressive course of the left breast locally advanced malignant process, (BIRADS 6).
- Right normal study, (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / مريم سعد شحاته خليل	Request No.	: 13003877
Patient No.	: 306-2025	Request Date	: 05/10/2025
Path No.	: 3003/25	Verification Date	: 12/10/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post-NACT.
Nature Of Specimen: Left modified radical mastectomy.

Gross Examination:
* Left modified radical mastectomy specimen measured 17x17x4 cm, with covering skin measured 10x07 cm. Nipple & areola looked unremarkable grossly.
* Serialling showed a tumor bed site 10x7x3 cm, located 0.4 from the least deep margin.
* Axillary fat measured 7x4x2 cm, entangling 15 lymph nodes, the largest was 1x1x0.5 cm.
* 16 Blocks:
1:10- T.B.S., 11- N&A., 12- Deep margin., 13:16- ALNs.
- Gross was done by; Dr. Heba Hassan.

Microscopic Examination:
* Histological type: No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor.
- Cellularity (0%).
* Angioinvasion: Absent.
* Ductal carcinoma in situ: Absent.
* Nipple & areola: Free.
* Deep margin: Free.
* Axillary lymph nodes: Fifteen lymph nodes free of metastatic deposits (0/15).
* Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.

Diagnosis:
Left breast cancer (Post-NACT), Left modified radical mastectomy:
- No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor.
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Deep Margin: Free.
- Nipple & areola: Free.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / مريم سعد شحاته خليل	Request No.	: 13003877
Patient No.	: 306-2025	Request Date	: 05/10/2025
Path No.	: 3003/25	Verification Date	: 12/10/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Axillary lymph nodes: Fifteen lymph nodes free of metastatic deposits, LNs (0/15).
- Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.
- Stage: ypT0, ypN0.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt